



# Guide Clinique des Urgences Parodontales

---

Du Diagnostic à la Prise en Charge Immédiate

**Pr. M. MEDDAD**  
**Pr. A. MAHFOUD**  
2025-2026

*Un guide de révision essentiel, conçu pour la clarté et la rétention.*



# Le Scénario d'Urgence : Pourquoi Maîtriser ce Sujet est Crucial

Certaines maladies parodontales évoluent vers des situations d'urgence, associées à des douleurs aiguës et des altérations fonctionnelles. Votre rôle est d'intervenir de manière rapide, précise et efficace. Toute prise en charge commence impérativement par une anamnèse médicale complète.

## Nos Objectifs Pédagogiques :

- ✓ Reconnaître les principales urgences parodontales.
- ✓ Établir un diagnostic rapide et précis.
- ✓ Mettre en place une prise en charge immédiate et adaptée.
- ✓ Prévenir les complications locales et systémiques.

## Légende de Révision

-  [QX] = Point testé lors d'un examen précédent.
-  = Point à forte probabilité d'être à l'examen.





# Fiche d'Intervention 1 : L'Abscès Gingival

## Définition

Une infection purulente, localisée et limitée à la gencive marginale.

## Signes Cliniques Clés

- Tuméfaction rouge, lisse et brillante, pouvant devenir pointue.
- Le pus peut s'échapper spontanément ou à la pression via un orifice fistuleux.
- **Signes radiologiques:** Généralement absents, ce qui est un critère de diagnostic différentiel important.

## Étiologie (Causes principales)

- Présence de corps étranger impacté dans le sulcus [Q2]:
  - Poils de brosse à dents, morceau de cure-dents, particule alimentaire.
- Obturation défectueuse proche de la gencive.
- Complication d'une gingivite préexistante.

## Traitement d'Urgence

1. **Drainage:** Incision simple pour évacuer le pus.
2. **Débridement:** Élimination du corps étranger ou de la cause irritante.
3. **Correction:** Reprise du traitement défectueux si nécessaire.





# Fiche d'Intervention 2 : L'Abcès Parodontal (Diagnostic)

Aussi appelé abcès pariétal ou latéral. C'est une infection purulente localisée au niveau des tissus parodontaux profonds, liée à une poche parodontale préexistante.

## (Colonne 1) Signes Cliniques Locaux

- Œdème gingival avec érythème.
- Douleur d'intensité variable (simple gêne à violente).
- Sondage révélant une poche parodontale profonde.
- Suppuration spontanée ou à la pression.
- Mobilité dentaire et sensibilité à la percussion.
- Sensation de 'dent longue' (égression).
- Test de vitalité pulpaire positif. C'est un signe différentiel majeur avec un abcès d'origine endodontique.

## (Colonne 2) Signes Généraux & Radiologiques

### Généraux (inconstants)

- Fièvre, malaise, adénopathies cervicales.

### Radiologiques

- Parodontolyse avancée visible.
- Lésion radio-claire latérale à la racine.
- Élargissement de l'espace desmodontal.







# Abcès Parodontal : Étiologie & Microbiologie

## (Section 1) Étiologie : Quand se forme-t-il ?

Chez les patients avec maladie parodontale :

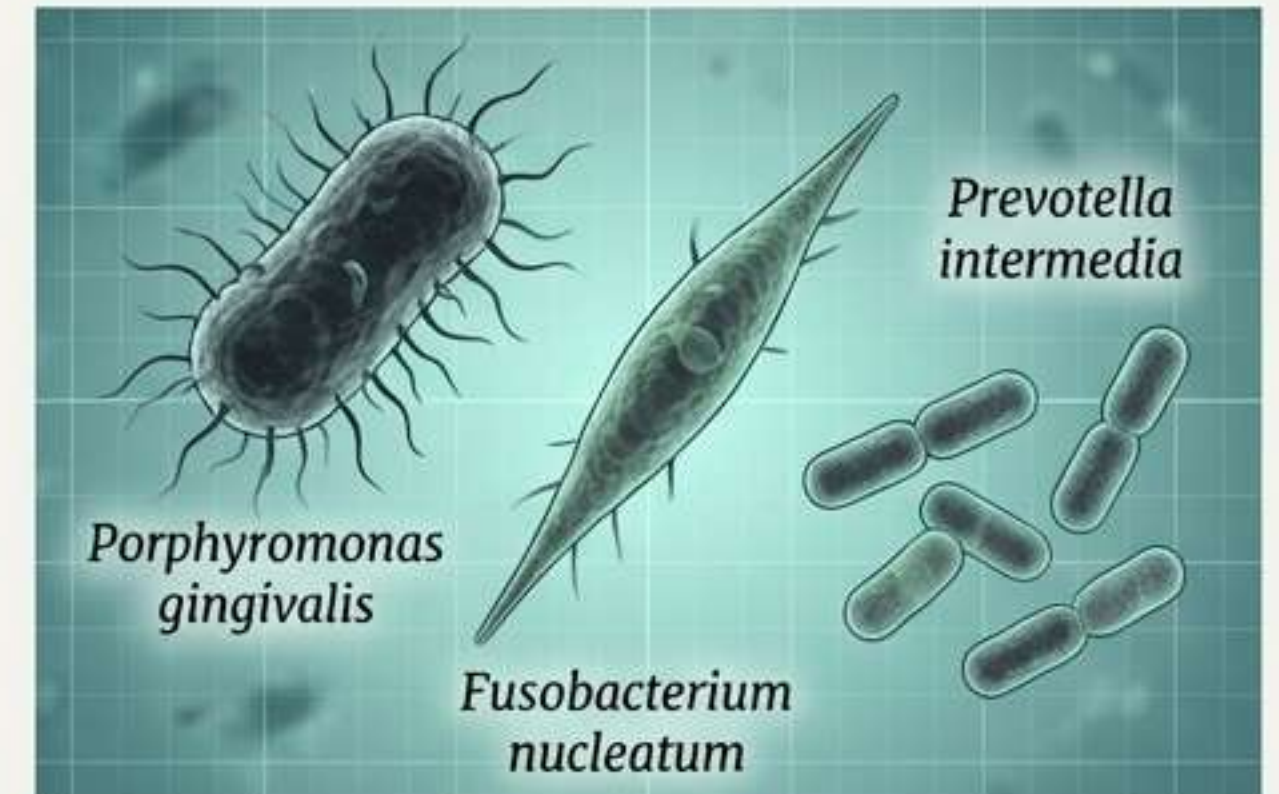
- Obstruction de l'orifice d'une poche parodontale [Q3] (ex: par un fragment de tartre), empêchant le drainage.
- Exacerbation aiguë d'une lésion chronique (baisse des défenses immunitaires).
- Traitement antibiotique systémique sans débridement local préalable (peut masquer et aggraver l'infection).

Chez les patients sans maladie parodontale :

- Perforation radiculaire lors d'un traitement endodontique [Q3].
- Fracture radiculaire verticale.
- Corps étranger impacté [Q3] (similaire à l'abcès gingival mais plus profond).

## (Section 2) Microbiologie : Qui sont les coupables ?

- L'abcès parodontal est une infection polymicrobienne.
- Il existe une grande similitude entre la flore des abcès parodontaux et celle des parodontites chroniques [Q1].
- **Bactéries dominantes:** Bacilles Gram négatif, anaérobies stricts.
  - *Porphyromonas gingivalis* (très virulent, retrouvé dans 50-100% des cas).
  - *Prevotella intermedia*.
  - *Fusobacterium nucleatum*.





# Abcès Parodontal : Protocole de Traitement d'Urgence

## 1

### (Étape 1) Drainage de la collection purulente

Objectif : Soulager la pression et la douleur.



Deux approches possibles :

- **Voie 1 : Drainage par la poche (sulculaire) [Q5, Q6].** Sous anesthésie, une sonde ou une curette est insérée dans la poche pour permettre l'évacuation du pus.
- **Voie 2 : Drainage par incision externe [Q6].** Si la collection est très fluctuante, une incision verticale est réalisée au centre de la tuméfaction.

## 2

### (Étape 2) Débridement et assainissement

Détartrage et surfaçage radiculaire (manuel ou ultrasons) pour éliminer les irritants.

Irrigation de la poche avec une solution saline ou un antiseptique (Chlorhexidine, Polyvidone iodée).

## 3

### (Étape 3) Soulagement et prescription

**Ajustement occlusal:** Indispensable si la dent est égressée pour soulager le patient.

**Antalgiques:** Paracétamol ou paracétamol codéiné.

**Antibiothérapie Systémique: NON SYSTÉMATIQUE [Q5].**

- Indiquée SEULEMENT si présence de signes généraux (fièvre, malaise, adénopathie), si la collection est diffuse, ou si le drainage est impossible.

Exemple : Amoxicilline 2g/j pendant 7 jours.





# Fiche d'Intervention 3 : La Gingivite Ulcéro-Nécrotique (GUNA)

Une maladie infectieuse et inflammatoire aiguë de la gencive, évoluant rapidement vers l'ulcération puis la nécrose de la gencive marginale et des papilles.

## Étiologie Multifactorielle

---

### (Colonne 1) Facteurs Déclenchants

- **Bactériens:** Association fusospirillaire [Q7] (Fusobactéries, Spirochètes, *Prevotella intermedia*).
- **Viraux:** Impliqués dans les formes récidivantes [Q7] (Cytomégalovirus, VIH/Sida).

### (Colonne 2) Facteurs Favorisants (Le 'Terrain')

- **Le Stress:** Niveaux élevés de corticostéroïdes observés (ex: militaires).
- **Le Tabac:** 98% des patients atteints de GUNA sont fumeurs (Pindborg, 1951).
- **Immunodépression:** Le VIH est un facteur de risque majeur.
- **Hygiène bucco-dentaire:** Une mauvaise hygiène est un facteur d'aggravation majeur [Q7].
- **Gingivite préexistante:** La GUNA débute souvent sur une gingivite marginale simple.



# GUNA : Reconnaître les Signes Cliniques et Agir



## Signes Locaux (Le Triptyque Pathognomonique)

- Douleurs (algies) gingivales [Q8]: Intenses, spontanées, invalidantes.
- Gingivorragies [Q8]: Saignements spontanés ou facilement provoqués.
- Nécrose papillaire [Q8]: L'aspect de "papilles décapitées" est le signe le plus révélateur de la maladie.

**\*\*Autres signes locaux\*\*:**

- Enduit blanc-grisâtre (pseudomembrane) [Q8] recouvrant les zones nécrosées.
- Érythème linéaire en bordure des lésions.
- Halitose fétide caractéristique.



## Signes Régionaux et Généraux

- Adénopathies sub-mandibulaires.
- Fièvre, malaise, anorexie dans les cas sévères [Q8].



## Prise en Charge d'Urgence

1. Symptomatique: Antalgiques, bains de bouche antiseptiques, et antibiotiques (Pénicillines ou Métronidazole).
2. Étiologique (dès que possible): Détersion douce des lésions avec H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> ou Chlorhexidine, suivie d'un débridement aux ultrasons si la douleur le permet.





# Fiche d'Intervention 4 : Le Syndrome du Septum

## Définition

Une forme d'ostéite alvéolaire aiguë et localisée qui touche le septum interdentaire, suite à un tassement alimentaire.

## Signes Cliniques

- Douleur vive et lancinante, surtout pendant les repas ('envie de cureter la dent').
- Papille interdentaire tuméfiée et saignante.
- **Signe Pathognomonique:** La pression digitale de la papille interdentaire provoque une douleur exquise, très différente de celle d'un septum sain.
- **Signes Radiologiques:** Lyse du septum interdentaire (en cratère si septum large, horizontale si septum étroit).

## Étiologie Principale

- La perte ou l'altération d'un point de contact fonctionnel entre deux dents [Q9], qui cause le 'bourrage alimentaire'.
- **Causes fréquentes:** Carie proximale, fracture de crête marginale, restauration débordante ou mal ajustée, malpositions dentaires.

## Traitement d'Urgence

- Le traitement est à la fois symptomatique et étiologique [Q9].
  1. **Symptomatique:** Anesthésie locale, curetage des tissus de granulation et nettoyage de la zone (antiseptiques).
  2. **Étiologique:** Élimination du corps étranger, et surtout, **rétablissement d'un point de contact correct** (réfection de l'obturation, ajustement de la prothèse).







# Fiche d'Intervention 5 : La Péricoronarite

## Définition et Contexte

- Inflammation aiguë du tissu gingival (capuchon muqueux ou opercule) recouvrant la couronne d'une dent qui n'a pas encore achevé son éruption.
- Concerne principalement les dents de sagesse (troisièmes molaires), surtout mandibulaires (troisièmes molaires), surtout mandibulaires [Q11].

## Signes Cliniques

- Tuméfaction rouge et douloureuse du capuchon muqueux.
- Suppuration possible.
- Limitation de l'ouverture buccale (trismus).
- Douleur irradiant vers l'oreille et la gorge.
- Adénopathie, mauvaise haleine, et parfois fièvre.

## Mécanisme Étiologique



1. Accumulation de plaque



2. Inflammation & Œdème



3. Traumatisme Occlusal



# Péricoronarite : Prise en Charge et Traitement

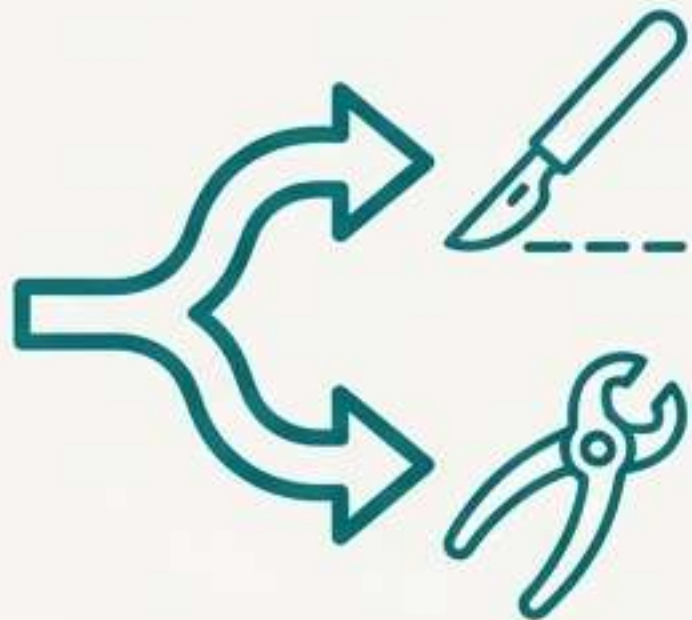
## Protocole en Phase Aiguë (Traitement Symptomatique)



- **Nettoyage / Drainage:**
  - Le premier geste est le nettoyage et le débridement sous le capuchon à l'aide d'une curette et l'irrigation avec un antiseptique (ex: eau oxygénée) [Q10].
- **Antibiothérapie:**
  - N'est PAS systématique [Q12].
  - Indiquée uniquement si l'état général est altéré (fièvre) ou en cas d'extension régionale de l'infection (cellulite).
- **Antalgiques:** Pour soulager la douleur.

---

## Après Refroidissement de l'Épisode Aigu (Traitement Étiologique)



Une fois l'inflammation contrôlée, une décision doit être prise :

- Option 1 : **Excision du capuchon muqueux (operculectomie)** si la dent a une position fonctionnelle sur l'arcade.
- Option 2 : **Extraction de la dent de sagesse** si elle est mal positionnée ou risque de générer des récurrences ou d'autres perturbations.



# Urgences Parodontales : Fiches de Référence Rapide



## Gingivorrhagie

**Définition:** Saignement abondant des gencives, spontané ou provoqué.

**Étiologie Clé:** Peut être locale (gingivite, parodontite, traumatisme) ou le signe d'une maladie systémique (troubles de l'hémostase).

### Action d'Urgence:

Détartrage/surfaçage de la zone, écouvillonnage à l'eau oxygénée, prescription de bains de bouche (Chlorhexidine). Si une cause systémique est suspectée, orienter vers un médecin.



## Mobilité Dentaire Accrue

**Définition:** Augmentation de l'amplitude du déplacement d'une dent. Motif d'inquiétude majeur pour le patient.

**Étiologie Clé:** Peut être réversible (traumatisme occlusal, inflammation) ou irréversible (perte de support osseux avancée).

**Action d'Urgence:** Le traitement dépend de la cause.

Ajustement occlusal sélectif, contention immédiate si traumatisme, traitement anti-inflammatoire, ou extraction en dernier recours.

| Types de Mobilité     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobilité transitoire  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mobilité physiologique : due aux hormones sexuelles durant la grossesse, à une désocclusion prolongée pendant le sommeil.</li><li>- Mobilité iatrogène : due aux actes odontologiques (traitement chirurgicaux, endodontique).</li></ul>                                                                                 |
| Mobilité réversible   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Étiologie inflammatoire (inflammation des tissus parodontaux, inflammation pulpaire, nécrose)</li><li>- Étiologie prothétique : effet des crochets ou des attachements en prothèse adjointe partielle, élément fixés en extension mal répartis.</li><li>- Étiologie occlusale : traumatisme occlusal, bruxisme</li></ul> |
| Mobilité irréversible | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mobilité consécutive à la perte du support osseux</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |



## Pulpite 'a Retro'

**Définition:** Inflammation pulpaire ('rage de dent') d'origine parodontale. L'infection atteint la pulpe par voie rétrograde (via l'apex ou des canaux accessoires).

**Signes Clés:** Douleurs de pulpite sur une dent à couronne intacte mais présentant une poche parodontale profonde.

**Action d'Urgence:** Le traitement est mixte et combine une approche endodontique (traitement canalaire) et parodontale (surfaçage radiculaire).



# Le Tableau de Diagnostic Différentiel



## Abcès Parodontal vs. Abcès Péri-apical vs. GUNA



| Critère de Distinction         | Abcès Parodontal                  | Abcès Péri-apical (Endodontique)                | Gingivite Ulcéro-Nécrotique (GUNA)                                |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Douleur                        | Sourde, continue, localisée       | Intense, pulsatile, diffuse                     | Très intense, généralisée, constante                              |
| Test de Vitalité Pulpaire      | Positive                          | Négative (dent nécrosée)                        | Non applicable (dents vivantes)                                   |
| Cause Principale               | Poche parodontale préexistante    | Carie profonde / Traumatisme / Nécrose pulpaire | Association bactérienne sur un terrain favorisant (stress, tabac) |
| Localisation de la Tuméfaction | Latérale, sur la gencive attachée | Apicale, dans le vestibule                      | Pas de tuméfaction, mais une nécrose généralisée                  |
| Sondage Parodontal             | Poche profonde et étroite         | Généralement normal (sauf si fistule)           | Sondage impossible et très douloureux                             |
| Signes Radiologiques           | Perte osseuse latérale/angulaire  | Lésion radio-claire à l'apex de la dent         | Pas de signes osseux (atteinte gingivale)                         |
| Signe Visuel Clé               | Fistule latérale                  | Fistule apicale                                 | Papilles 'décapitées', pseudomembrane                             |

**Note:** La capacité à différencier ces lésions est un point clé de l'évaluation clinique [Q4].



# Au-Delà de l'Urgence : Le Rôle du Chirurgien-Dentiste

*Les urgences parodontales, bien que rares, peuvent entraîner des destructions tissulaires irréversibles. La prise en charge de l'urgence est essentielle, mais notre rôle le plus important réside dans la prévention.*

## Les Piliers de la Prévention



**Dépistage Précoce:** Identifier et traiter les maladies parodontales avant qu'elles n'atteignent un stade aigu.



**Motivation du Patient:** Éduquer à une hygiène bucco-dentaire rigoureuse et à l'importance du suivi régulier.



**Traitement en Temps Opportun:** Instaurer une thérapeutique parodontale complète pour stabiliser la maladie et prévenir les récives.

**Le succès ne se mesure pas seulement à la qualité de notre intervention d'urgence, mais à notre capacité à la rendre inutile.**



# Checklist d'Action en Situation d'Urgence

## Abcès Parodontal



1. ☐ Anesthésie locale.
2. ☐ **Drainage** (par la poche ou par incision).
3. ☐ **Débridement** et surfaçage de la racine.
4. ☐ Irrigation antiseptique.
5. ☐ Ajustement occlusal si nécessaire.
6. ☐ Prescription : Antalgiques ± Antibiotiques (si signes généraux).

## Gingivite Ulcéro-Nécrotique (GUNA)



1. ☐ Prescription initiale : Antibiotiques (Métronidazole/Pénicilline), Antalgiques, Antiseptiques.
2. ☐ **Détersion** douce des pseudomembranes ( $H_2O_2$ ).
3. ☐ **Débridement** aux ultrasons (dès que la douleur le permet).
4. ☐ Instructions d'hygiène rigoureuses et arrêt du tabac.
5. ☐ Planification du traitement parodontal complet.

## Péricoronarite Aiguë



1. ☐ Anesthésie locale.
2. ☐ **Irrigation et nettoyage** sous le capuchon muqueux.
3. ☐ Soulagement de l'occlusion si traumatisme de la dent antagoniste.
4. ☐ Prescription : Antalgiques ± Antibiotiques (si signes généraux/extension).
5. ☐ Planification post-crise : Excision du capuchon ou extraction de la dent.